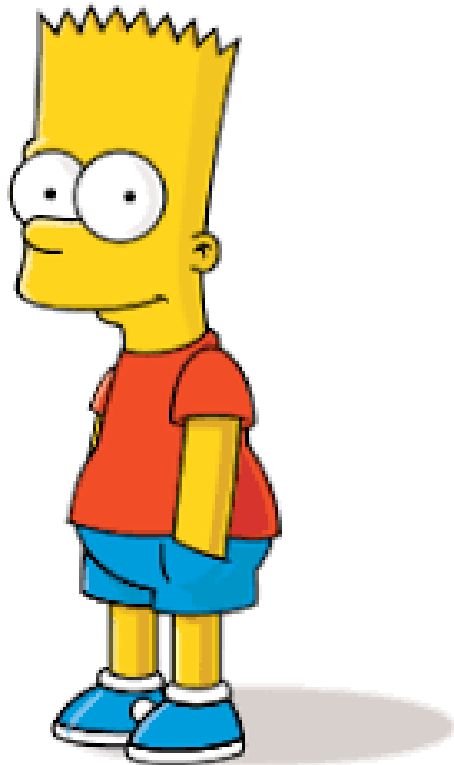


Conduite a tenir devant un ictère



Dr. MENOURA. R

Maitre-assistant Hepato-biliopancreatique
Service de chirurgie digestive , viscérale et
endocrinienne

E.H. DIDOUCHE MOURAD

CONSTANTINE 2025/2026

Objectifs d'apprentissage

- ❑ Savoir reconnaître un ictère, évaluer sa gravité et prioriser les actions.
- ❑ Conduire une démarche diagnostique **rapide, logique et rentable**.
- ❑ Différencier **ictère pré-hépatique, hépatique, post-hépatique**.
- ❑ Prescrire **les bons examens** (ordre, indications, interprétation).
- ❑ Initier **les premières mesures thérapeutiques** et savoir **quand référer/hospitaliser**.

Définition

L'ictère est une coloration jaune des téguments (peau et muqueuses) liée à une augmentation du taux sérique de la bilirubine.

Chez l'adulte, la bilirubinémie normale est inférieure à 17 $\mu\text{mol/l}$.

Quand ce taux est compris entre 30 $\mu\text{mol/l}$ et 50 $\mu\text{mol/l}$, l'ictère n'est visible qu'au niveau des muqueuses ; on parle d'un « subictère » qui est recherchée à la lumière du jour.

L'ictère franc apparaît lorsque la bilirubinémie dépasse 50 $\mu\text{mol/l}$.

Peut être conjugué (direct) ou non conjugué (indirect).

Physiopathologie simplifiée

- **Production** de bilirubine → dégradation de l'hémoglobine.
- **Transport** → liaison à l'albumine.
- **Métabolisme hépatique** → conjugaison par UDP-glucuronyl transférase.
- **Excrétion biliaire** → élimination dans l'intestin.

Un défaut à n'importe quelle étape = ictère.

Classification des ictères

1. Pré-hépatique (hémolytique)

1. Excès de production (anémie hémolytique, paludisme...).
2. Bilirubine **libre** ↑.

2. Hépatique (intrahépatique)

1. Défaut de captation, conjugaison ou excrétion (hépatite virale, cirrhose, tumeurs...).
2. Bilirubine **mixte**.

3. Post-hépatique (cholestatique, obstructif)

1. Obstacle à l'écoulement de la bile (lithiase, tumeur de la voie biliaire ou pancréas).
2. Bilirubine **conjugée** ↑

Physiologie

Le métabolisme de la bilirubine passe par 4 principales étapes.

1. Etape sérique du métabolisme de la bilirubine :

La bilirubine provient principalement du catabolisme de l'hémoglobine (produit de dégradation des globules rouges sénescents assurée par les macrophages).

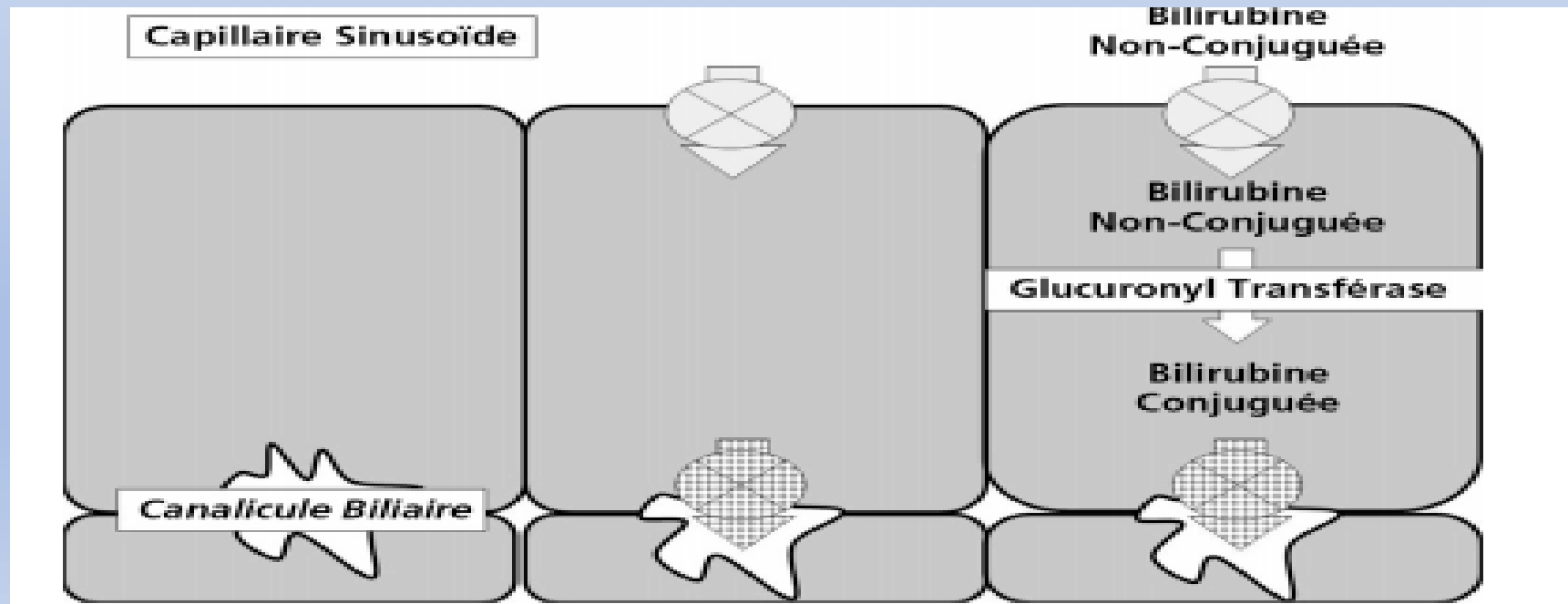
peu soluble en milieu hydrique et presque totalement liée à l'albumine

De ce fait, la bilirubine non conjuguée ne peut franchir la barrière glomérulaire normale

Il n'y a donc pas de bilirubine non conjuguée dans les urines.

2. Etape hépatocytaire du métabolisme de la bilirubine :

Dans le cytoplasme hépatocytaire, la bilirubine est liée à d'autres protéines et acheminée vers le réticulum endoplasmique. La bilirubine glucuronide transférase (ou UDP-glucuronyltransférase) de la membrane du réticulum endoplasmique conjugue la bilirubine avec l'acide glucuronique.



3. Etape de sécrétion de la bilirubine :

La bilirubine forme avec les acides biliaires et le cholestérol la bile. Ainsi la bilirubine est sécrétée par la bile grâce à un transport actif, saturable, compétitif et sélectif.



4. Etape intestinale :

La bilirubine est éliminée dans le tube digestif, où elle est transformée en **urobilinogène** sous l'action des **bactéries intestinales**. La plus grande partie de ces urobilinogènes est éliminée dans **les matières fécales auxquelles** ils donnent leurs **colorations marrons**. Une **petite partie** de ces urobilinogènes est **réabsorbée** par l'intestin. Une fraction est éliminée **dans les urines**. Une fraction est captée par le foie et éliminée dans **la bile** : c'est le **cycle entéro-hépatique.** ».

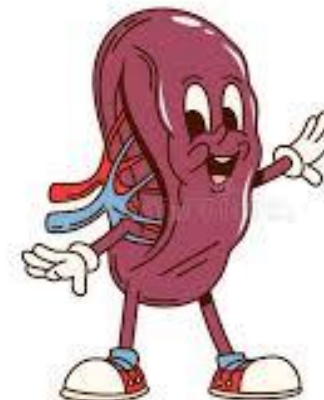


180 JOURS

HEME



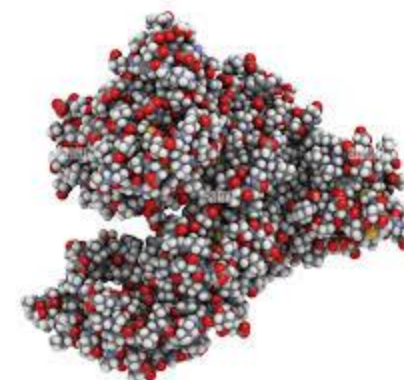
MACROPHAGE



BRBINE DONT LIKE WATER

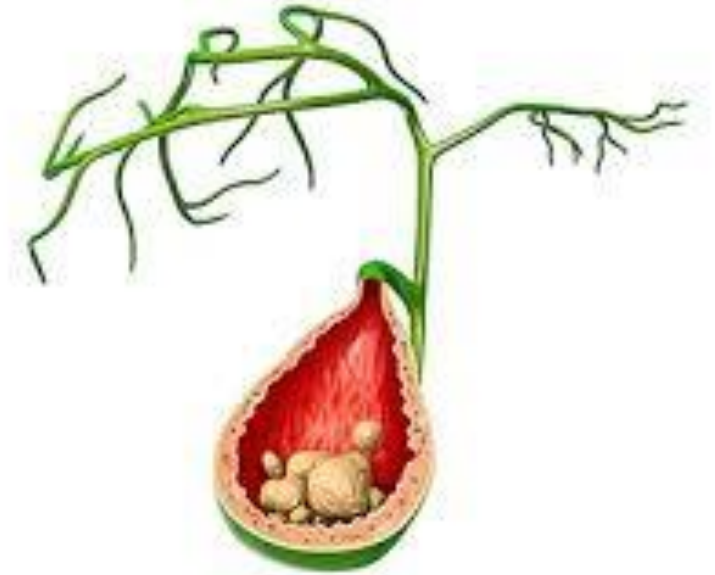
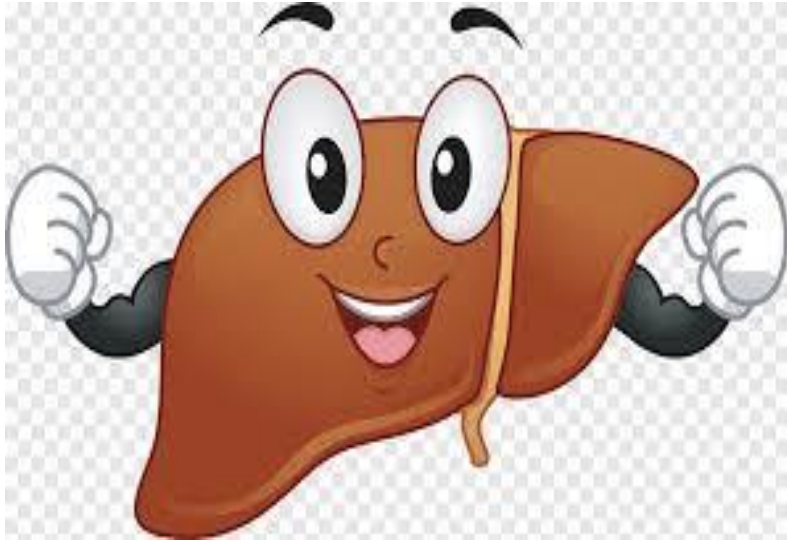


ALBUMINE



alamy





ACIDE GLUCURONIQUE
+ BILIRUBINE
=
CONJUGAISON



UDP GLUCURONYL
TRANSFERASE

BILIRUBINE CONJUGUEE



UROBILINOGENE

10 / 15%



Une partie absorbée va t être acheminer vers le foie

Cycle enterohepatique

90/ 85%



BACTERIES

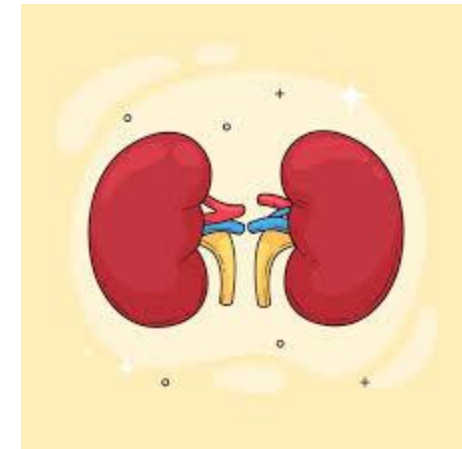


STERCOBILINE



STERCOBILINOGENE

L autre partie
urobiline



Démarche initiale (triage et urgence)

l'évaluation de la gravité

Signes vitaux : T°, FC, TA, SpO₂.

Signes de sepsis/angiocholite : fièvre, frissons, douleurs de l'hypochondre droit/épigastre, confusion, hypotension (→ **pentade de Reynolds = urgence vitale**).

Insuffisance hépatique aiguë : astérisis, confusion/encéphalopathie, **TP/INR altéré**, hypoglycémie, ictère rapidement progressif

Cholestase gravidique sévère ou ictère néonatal/infantile : **situations spécifiques** (référer rapidement).

Conduites immédiates si gravité !!!!!

- **Mise en condition** : voie veineuse, remplissage si besoin, antalgiques, antiémétiques.
- **Prélèvements** : **NFS, CRP, bilan hépatique complet, hémocultures** si fièvre.
- **Antibiothérapie probabiliste** si **angiocholite suspectée** (adapter au contexte local et à l'écologie).
- **Appeler chirurgie digestive/GE** pour **drainage biliaire** en urgence si choc/sepsis persistant

1) Interrogatoire orienté (check-list)

- **Début & évolution** : brutal (lithiase) vs progressif (tumeur, cholangite sclérosante).
- **Douleurs** : colique hépatique ? irradiation dorsale (pancréas) ?
- **Fièvre/frissons** : infection biliaire.
- **Prurit, urines foncées, selles décolorées** : cholestase.
- **Expositions** : alcool, drogues IV, rapports sexuels non protégés, voyages, eau/aliments à risque (hépatites A/E).



- **Médicaments & toxiques** (hépatotoxicité) : paracétamol (surdosage), anti-TB, amoxicilline-ac.clav., statines, antipsychotiques, antibiotiques macrolides, antifongiques, plantes.
- **ATCD** : hépatites virales, cirrhose, lithiase, chirurgie biliaire, maladies auto-immunes (CBP, HAI), maladies hématologiques (hémolyse).
- **Terrain** : âge, grossesse, IMC, diabète, immunodépression.
- **Contexte familial** : Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson, Rotor.

Examen clinique (ce qu'il faut chercher)

- **Coloration** : conjonctives (précoce), peau; gratter → lésions de grattage.
- **Douleur** : Murphy +/-, défense HCD, masse épigastrique (tête pancréas).
- **Foie/Rate** : hépatomégalie, splénomégalie (hypersplénisme/hémolyse/HTP).
- **Signes de cirrhose** : angiomes stellaires, érythème palmaire, ascite, circulation collatérale.
- **Encéphalopathie** : astérixis, confusion.
- **Sepsis** : ictère + fièvre + douleur = **triade de Charcot** (penser angiocholite).

Examens complémentaires – quoi prescrire, dans quel ordre ?

A. Biologie (1^{re} intention pour tous)

- 1) **Bilirubine totale et fractionnée** (directe/indirecte).
- 2) **Transaminases (ASAT/ALAT), PAL, γ GT.**
- 3) **NFS** (anémie, hémolyse), **réticulocytes, LDH, haptoglobine, frottis** si hémolyse suspectée.
- 4) **TP/INR, albumine, glucose** (fonction hépatique/synthèse).
- 5) **Ions, créatinine** (co-morbidités, préparation aux examens/contrastés).
- 6) **Sérologies** selon contexte : HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, HCV Ac $\pm$ ARN, HEV IgM (grossesse), VIH.
- 7) **Auto-immun** (si cytolyse/cholestase inexpliquées) : ANA, ASMA, LKM, AMA, IgG/IgM.
- 8) **Dosages ciblés** : ferritine, transferrine, céruloplasmine (<40 ans), alpha-1 antitrypsine, bilan thyroïde.

1) Échographie abdominale (examen de 1re intention) :

- Dilatation des **voies biliaires** intra/extra-hépatiques ?
- Présence de **calculs, boues, masse** hépatique/pancréatique/vésiculaire ?
- **Vésicule** : distension, parois, sludge, calculs, signe de Murphy échographique.

2) Si voies dilatées ou suspicion d'obstacle :

- **TDM abdominale** (pancréas, VBP) ± **IRM/CP-IRM** pour cartographier l'obstacle.

3) Si geste thérapeutique attendu :

- **CPRE** (extraction calculs, sphinctérotomie, stent) – à discuter avec GE.

4) Si CPRE impossible/échec :

- **Drainage biliaire percutané** (radiologie interventionnelle).

Arbre décisionnel pratique

1. **Ictère confirmé** (clinique + BT > 30–40 $\mu\text{mol/L}$).
2. **Gravité ?** (sepsis, choc, confusion, TP/INR $\uparrow$) → **hospitaliser/urgence**.
3. **Pattern biologique** :
 - Indirecte prédominante → **rechercher hémolyse**.
 - PAL/ γ GT très $\uparrow$, urines foncées, selles pâles → **cholestase**.
 - ALAT/ASAT très $\uparrow$ → **hépatique** (hépatite aiguë, toxique).
4. **Échographie** : voies **dilatées** = **obstacle** → TDM/IRM → **CPRE/Drainage**.
5. **Voies non dilatées** = cause **hépatique** (hépatite, CBP/PSC, DILI, infiltration) → bilans ciblés, hépatologie.

Prises en charge par étiologie (principes)

A. Ictère pré-hépatique (hémolytique)

- **Identifier la cause** : hémolyse auto-immune (test de Coombs), paludisme, drépanocytose, déficit G6PD, microangiopathies, prothèses valvulaires, toxiques.
- **Conduites** :
 - Traitement **étiologique** (antipaludique, arrêt toxique, corticothérapie si AHA1, transfusion si besoin, folates).
 - Surveillance **hémodynamique**, diurèse, bilan fer.

B. Ictère hépatocellulaire

- **Causes** : hépatites virales, toxicité médicamenteuse (DILI), alcool, ischémie, auto-immunes, métaboliques (Wilson, hémochromatose), infiltration tumorale.
- **Conduites** :
 - Arrêt **immédiat** des toxiques/médicaments suspects.
 - Hépatite virale aiguë : traitement de support ± antiviral selon type/gravité.
 - Suspicion **insuffisance hépatique aiguë** (TP/INR altéré, encéphalopathie) → **référer en centre spécialisé** (évaluation transplantation).

Ictère cholestatique post-hépatique (obstructif)

- **Causes fréquentes** : lithiase de **VBP**, tumeur tête pancréas/ampoule de Vater/CHC cholangiocarcinome, sténoses (post-CPRE, **PSC**), parasitoses (selon régions).
- **Conduites** :
 - **Angiocholite** (sepsis) : antibiothérapie IV probabiliste, réanimation si besoin, **drainage biliaire urgent** (CPRE en 1er si accessible).
 - Lithiase non compliquée : extraction endoscopique, cholécystectomie secondaire.
 - Masse tumorale : bili-MRI/TDM de staging, **drainage** si ictère cholestatique symptomatique/prurit/infection ou avant chirurgie/chimio (discussion RCP).

Focus Angiocholite (urgence)

- **Diagnostic clinique** : triade de Charcot = **douleur HCD** + **fièvre** + **ictère**. Gravité si **hypotension/confusion** (pentade de Reynolds).
- **Biologie** : cholestase, cytolyse variable, leucocytose/CRP, hémocultures.
- **Imagerie** : écho initiale; TDM/IRM si doute; CPRE thérapeutique.
- **Prise en charge** :
 - Réanimation : VVP, remplissage, antalgie, monitoring, hémocultures.
 - **Antibiothérapie IV** couvrant entérobactéries + anaérobies (adapter aux protocoles locaux, terrain, ATB récents, résistance locale).
 - **Drainage biliaire** (CPRE en priorité) dès que possible si sepsis persistant/obstacle.

Situations particulières

- **Grossesse** : penser **cholestase intrahépatique gravidique**, HEV, prééclampsie/HELLP, lithiase; bilan et imagerie **non irradiants** (écho/IRM sans gadolinium si besoin). Collaboration obstétrique.
- **Sujet âgé** : étiologies néoplasiques/lithiasiques ++ ; attention aux **médicaments** et **fonction rénale**.
- **Pédiatrie** : ictère néonatal/prolongé → causes spécifiques (atrésie biliaire, infections, métaboliques) → référer pédiatrie spécialisée.

Immunodéprimé : infections opportunistes, médicaments; bilan élargi

Erreurs fréquentes à éviter

Retarder l'**échographie** en première intention.

- Prescrire des **ATB** sans hémocultures si fièvre.
- **Oublier l'INR/TP** et l'évaluation de la **gravité** (encéphalopathie, hypoglycémie).
- Interpréter une **bilirubine isolée** sans fractionnement (directe/indirecte).
- Négliger l'**iatrogénie** médicamenteuse.

biologie

Objectif : confirmer l'ictère, préciser le mécanisme (**cholestase vs cytolyse vs hémolyse**) et orienter vers la cause

Paramètre	Intérêt	Profil biologique
ASAT (AST) et ALAT (ALT)	Évaluation cytolyse hépatique	> 10N : atteinte hépatocellulaire
Phosphatases alcalines (PAL)	Marqueur cholestase	↑ franche dans cholestase
Gamma-GT	Confirme origine hépatobiliaire de la PAL	↑ dans cholestase et alcoolisme
LDH	Aide au diagnostic d'hémolyse ou d'hépatite aiguë	↑ si hémolyse ou cytolyse sévère

C. Exploration de la fonction hépatique

Paramètre

TP (taux de prothrombine)

Albumine

INR

Intérêt

Allongé si insuffisance hépatique ou carence en vitamine K

Baisse = insuffisance hépatique chronique

Alternative au TP

E. Examens complémentaires ciblés

- **Sérologies virales** : VHA, VHB, VHC, HEV, CMV, EBV
- **Auto-anticorps** : ANA, ASMA, LKM, AMA
- **Bilan ferrique**, céruloplasmine, alpha-1-antitrypsine
- **Marqueurs tumoraux** : CA 19-9, ACE (si suspicion tumorale)

Conduite à tenir pratique

- 👉 **Étape 1 : Confirmer l'ictère** (clinique + bilirubine > 30 $\mu\text{mol/L}$).
- 👉 **Étape 2 : Orienter par la clinique** (douleur, fièvre, prurit, évolution).
- 👉 **Étape 3 : Faire le bilan biologique** (cytolyse, cholestase, hémolyse).
- 👉 **Étape 4 : Imagerie adaptée** (échographie puis autres).
- 👉 **Étape 5 : Orienter le patient vers :**
 - **Urgence chirurgicale/infectieuse** : angiocholite, obstruction aiguë.
 - **Spécialité** : hépatologie, chirurgie digestive, oncologie

Étape	Objectif	Examens / Actions	Résultats attendus	Décision / Orientation
1. Confirmation	Confirmer qu'il s'agit bien d'un ictère	Observation clinique (peau, conjonctives, muqueuses) + dosage bilirubine totale	Bilirubine totale > 35 μ mol/L (> 2 mg/dL)	Passer à l'étape suivante
2. Interrogatoire	Identifier mode d'installation, signes associés, facteurs de risque	Antécédents, douleur, fièvre, prurit, amaigrissement, exposition toxique/médicamenteuse, ATCD biliaires ou hépatiques	Profil évolutif et contexte (aigu, chronique, post-chirurgie, intoxication)	Orienter vers cause probable
3. Examen clinique	Dépister urgence et étiologie probable	Constantes vitales, Triade de Charcot, masse abdominale, hépatomégalie, signes de cirrhose	Signes de sepsis, masse, maladie hépatique chronique	Décider urgence (ex. angiocholite) ou bilan complémentaire

4. Biologie

Différencier
cytolyse /
cholestase /
hémolyse

- Bilan hépatique
: bilirubine
conjuguée/non
conjuguée, ALAT,
ASAT, PAL, γ GT-
NFS, CRP,
hémocultures si
fièvre- LDH,
haptoglobine,
frottis sanguin-
Sérologies virales
hépatiques

Profil biologique
typique :-

Cytolyse →
hépatite-

Cholestase →
obstruction-

Hémolyse →
bilirubine libre

Choix de
l'imagerie adapté

5. Imagerie 1ère intention

Rechercher dilatation
voies biliaires ou
atteinte
parenchymateuse

Échographie
abdominale

- Dilatation → obstacle
mécanique- Pas de
dilatation → atteinte
intra-hépatique ou
hémolyse

Si obstacle : imagerie
complémentaire

6. Imagerie 2e intention

Préciser nature, siège,
extension

TDM abdominale, IRM
biliaire (cholangio-
IRM)

Localisation précise,
nature tumorale ou
lithiasique

Programmer geste
diagnostique/therape
utique

7. Endoscopie interventionnelle

Lever l'obstacle et
prélever si besoin

CPRE ou
échoendoscopie avec
biopsie

Restauration flux
biliaire, diagnostic
histologique

Définir stratégie
thérapeutique

8. Prise en charge spécifique

Traiter la cause

- Angiocholite : ATB IV
+ drainage urgent-
Tumeur : bilan
d'extension + chirurgie
ou stent- Hépatite :
traitement
étiologique- Hémolyse
: traitement cause

Stabilisation patient et
traitement définitif

Principes de traitement

- **Ictère hémolytique** → traiter cause (transfusion, corticoïdes, anti-paludéens...).
- **Ictère hépatocellulaire** → repos, antiviraux, arrêt toxiques, surveillance.
- **Ictère obstructif** :
 - Drainage biliaire (endoscopique ou percutané).
 - Chirurgie (lithiase, tumeur).
 - Antibiotiques si angiocholite

Points clés

- Toujours distinguer **conjugué vs non conjugué**.
- **Échographie** = examen de première intention.
- Devant un ictère fébrile et douloureux → penser **angiocholite (urgence)**.
- Devant un ictère progressif, indolore, avec prurit → suspecter **tumeur biliaire ou pancréatique**
- **Biologie + Écho** = duo de base.
- Toujours évaluer **la gravité et l'urgence**.
- Adresser au spécialiste dès suspicion d'obstacle ou d'hépatite sévère

21/09/2025 13:42:47

3 min

Dose (uGy* m^2) :

Acc. :



97%

21/09/2025 13:42:47

15 min

15MIN